ARAÇ 2 / 5

Karar Haritası: Çekim mi, Koruma mı?

Yedi soruda çekim kararını dişe değil yüze, kesici eğimine, vertikal yapıya, periodonsiyuma ve büyümeye göre verin.

BÖLÜM 1

Karar Ağacı: 7 Soru

Soruları sırayla yanıtlayın. Sağ sütunda toplanan "çekim lehine" işaretleri kararı netleştirir.

1 · Çapraşıklık: ark başına yer ihtiyacı ne kadar?

Şiddetli → Yer ihtiyacı büyük (çoğunlukla 7–8 mm üzeri): premolar çekimi güçlü aday. Kalan sorular hangi dişin çekileceğini belirler.

Hafif–orta → Önce koruma seçenekleri: IPR, genişletme, distalizasyon. Çekim ancak aşağıdaki sorular destekliyorsa.

2 · Yüze sorun: profil ve dudaklar ne söylüyor?

Protrüzif → Konveks profil, dolgun ve öne çıkık dudaklar, zorlanarak kapanan dudaklar: retraksiyon yüze yarar → **çekim lehine**.

Düz / konkav → İnce dudak, belirgin burun ve çene: retraksiyon profili düzleştirip dudak desteğini azaltabilir → **koruma lehine**.

3 · Kesici eğimi: kesiciler şu an nerede?

Proklinasyonda → IMPA ve U1-SN normalin belirgin üstünde: kesicileri daha öne iterek yer kazanma alanı kalmamış → **çekim lehine**.

Dik / retrokline → Kontrollü öne hareketle yer kazanılabilir (IMPA ~90° referans) → **koruma lehine**.

4 · Vertikal yapı: FMA ve overbite?

Yüksek açılı → FMA ~25° üzerinde, açık kapanış eğilimi: molar mesyalizasyonu ve vertikal kontrol çekimi destekler; çoğunlukla 2. premolar düşünülür.

Düşük açılı → Derin kapanış, güçlü kas yapısı: boşluk kapatma zorlaşır, derin kapanış artabilir → **koruma lehine**.

5 · Bolton: diş boyutları uyumlu mu?

Uyumsuz → Fazlalık altta ise alt kesici çekimi veya alt IPR; üstte küçük lateral varsa yer açıp restoratif planlayın. Çekim desenini buna göre seçin.

Uyumlu → Standart çekim desenleri (Bölüm 2) uygulanabilir; simetrik bitirme beklenir.

6 · Periodonsiyum: dişeti ve alveolar kemik izin veriyor mu?

Riskli → İnce biyotip, dişeti çekilmesi, dar simfiz: kesicileri öne ve yana itmeyin; genişletme ve proklinasyon sınırlı → çekim veya IPR.

Sağlıklı → Sınırlı genişletme ve kontrollü proklinasyon seçenek olarak açık kalır.

7 · Büyüme: hasta hangi dönemde?

Büyüyor → Kararı aceleye getirmeyin: RME, fonksiyonel aparey, süt molar–premolar boyut farkının (E-boşluğu) Nance veya lingual ark ile korunması yer ihtiyacını değiştirebilir.

Büyüme bitmiş → Yer yalnızca dentoalveolar yoldan gelir; iskeletsel uyumsuzluk büyükse kamuflaj sınırını ve cerrahi seçeneği konuşun.

Nasıl okunur

Şiddetli çapraşıklıkta premolar çekimi çoğunlukla kaçınılmazdır. Hafif–orta çapraşıklıkta ise karar, soru 2–6'daki "çekim lehine" işaretlerin sayısıyla verilir: işaret yoksa koruyun, işaretler birikiyorsa çekim planlayın.

Sık hata

Hafif–orta çapraşıklıkta sadece model ölçümüne bakıp çekmek. Çekim kesicileri retrokline edebilir, profili düzleştirip dudak desteğini azaltabilir. Karar her zaman yüz fotoğrafı ve sefalometri ile birlikte verilir.

İŞARET	ÇEKİM LEHİNE	KORUMA LEHİNE
Çapraşıklık	Şiddetli	Hafif–orta
Profil / dudak	Konveks, protrüzif dudak	Düz–konkav, ince dudak
Kesici eğimi	Proklinasyonda	Dik veya retrokline
Vertikal	Yüksek açılı, açık kapanış eğilimi	Düşük açılı, derin kapanış
Periodonsiyum	İnce biyotip, dar alveol	Kalın biyotip, geniş alveol
Büyüme	Bitmiş, kamuflaj sınırında	Atılım öncesi veya içinde

Sınırda vakada karar vermeden önce

- [ ] Profil ve gülümseme fotoğrafı yan yana değerlendirildi
- [ ] Ark başına yer ihtiyacı ve Bolton hesaplandı
- [ ] IMPA, U1-SN ve FMA kaydedildi
- [ ] Dişeti biyotipi ve alt ön bölge alveolar kalınlığı not edildi
- [ ] Büyüme dönemi belirlendi (el-bilek veya servikal vertebra)
- [ ] Molar bitiriş ilişkisi ve ankraj ihtiyacı yazıldı
- [ ] Seçenekler ve sınırları hastaya anlatıldı

BÖLÜM 2

Hangi Dişi Çekmeli?

Çekim deseni; ankraj ihtiyacını, kesici retraksiyon miktarını ve molar bitiriş ilişkisini belirler.

DESEN	NE ZAMAN	DİKKAT
4 × 1. premolar	Şiddetli çapraşıklık, belirgin bimaksiller protrüzyon; kesicilerde en fazla geri hareket istendiğinde.	Ankraj ihtiyacı yüksek; ince dudaklı hastada aşırı retraksiyon profili düzleştirir.
4 × 2. premolar	Orta çapraşıklık, sınırda vaka; profil iyi ve kesicilerin az geri gelmesi isteniyor; yüksek açılı hastada molar mesyalizasyonu.	Boşluk kapanırken molarlar öne gelir; kesici retraksiyonu sınırlıdır.
Üst 1. + alt 2. premolar	Sınıf II eğilimli vakada molar ilişkisini Sınıf I'e getirmek.	Üstte ankraj korunmalı, altta molar mesyalizasyonu istenir.
Üst 2. + alt 1. premolar	Hafif Sınıf III eğilimde dental kamuflaj.	Alt kesicilerin retraksiyonu çene simfizi ve periodonsiyumla sınırlıdır.
Sadece üst 1. premolarlar (2 diş)	Sınıf II kamuflaj: alt ark düzgün, büyüme bitmiş; overjet üst retraksiyonla kapanır.	Molarlar tam Sınıf II, kaninler Sınıf I bitirilir. Alt arkta çapraşıklık varsa uygun değildir.
Asimetrik çekim	Tek taraflı Sınıf II, orta hat sapması, bir tarafta eksik veya kötü prognozlu diş.	Orta hat ve kanin ilişkisini baştan planlayın; asimetrik mekanik ve ankraj gerekir.
Alt kesici çekimi	Alt ön bölgede Bolton fazlası, hafif Sınıf III eğilim, iyi posterior kapanış.	Overjet ve overbite artabilir; set-up ile önceden deneyin.
Kötü prognozlu diş	Geniş restorasyonlu, kanal tedavili veya hasarlı molar/premolar varsa sağlam diş yerine o diş.	Boşluk kapatma mekaniği uzayabilir; ankraj ve kök paralelliği planlanmalı.

Sık hata

Çekim desenini sadece çapraşıklığa göre seçmek. Molar bitiriş ilişkisini (Sınıf I mi, tam Sınıf II mi) çekimden önce yazın; desen ona göre çıkar.

BÖLÜM 3

Koruma Seçenekleri ve Sınırları

Çekimsiz yer kazanma yollarının her biri bir sınırla gelir. Sınırı aşan plan nüks ve periodontal sorun üretir.

SEÇENEK	NE ZAMAN İŞE YARAR	SINIR
IPR (stripping)	Hafif çapraşıklık, üçgen dişler, Bolton uyumsuzluğu, siyah üçgen riski.	Mine kalınlığı ile sınırlıdır; ağız hijyeni zayıf ve çürük riski yüksek hastada dikkat. Yüzeyler cilalanmalı.
Hızlı üst çene genişletmesi (RME)	İskeletsel transversal darlık, çapraz kapanış; sütür açık olan genç hasta.	Sütür olgunlaştıkça iskeletsel etki azalır; yetişkinde mini vida destekli seçenek veya cerrahi gündeme gelir.
Dentoalveolar genişletme	Dar ark, bukkal koridor geniş, posterior dişler lingual eğimli.	Kanin bölgesinde genişletme stabil değildir; ince bukkal kemikte dişeti çekilmesi riski.
Distalizasyon	Yer ihtiyacı az (birkaç mm), hafif Sınıf II molar ilişkisi; mini vida ankrajı ile daha öngörülebilir.	İkinci ve üçüncü molar durumu ve tüber alanı belirler; büyük yer ihtiyacında yetersiz kalır.
Kontrollü proklinasyon	Retrokline kesiciler, düz profil, kalın periodonsiyum.	Dar simfiz ve ince dişetinde risklidir; dudak protrüzyonu artar.
E-boşluğunun korunması	Karışık dişlenme, süt molarlar henüz düşmemiş.	Zamanlama kaçırılırsa yer kaybolur; Nance veya lingual ark ile erken koruma.

Kısa kural

Distalizasyon az yer ihtiyacında iyi çalışır. Yer ihtiyacı büyüdükçe ve dudaklar protrüzifleştikçe premolar çekimi daha öngörülebilir hale gelir.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Çekim veya koruma kararını verdiyseniz, uygulama ayrıntıları için **Modül 04 Yer Yönetimi: IPR, Genişletme, Çekimler ve Mini Vidalarla Ankraj** bölümünü açın. Sagital problemi netleştirmek için ardından **Araç 3 · Sınıf II – Sınıf III Görsel Ayırıcı**.